# Qualidade, Segurança e Experiênicia do Paciente

**SUMÁRIO**

**1. PROGRAMA DA DISCIPLINA..... 1**
1.1 EMENTA .....1
1.2 CARGA HORÁRIA TOTAL ..... 2
1.3 OBJETIVO..... 2
1.4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ..... 2
1.5METODOLOGIA..... 2
1.6 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ..... 3
1.7 BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA ..... 3
*CURRICULUM VITAE* DO PROFESSOR ..... 4
**2. TEXTO PARA ESTUDO**..... 4

# 1. PROGRAMA DA DISCIPLINA

## 1.1 Ementa

Gestão da qualidade em saúde. Melhoria da qualidade em saúde. Avaliação da qualidade em saúde. Segurança do paciente. Experiência do paciente.

## 1.2 Carga horária total

24 horas-aula

## 1.3 Objetivo

- aplicar os fundamentos da qualidade na gestão das organizações de saúde;
- realizar ciclos de melhoria efetivos;
- estruturar um conjunto de indicadores para o monitoramento do desempenho organizacional;
- escolher a metodologia de avaliação externa da qualidade de acordo com o contexto e a estratégia da organização de saúde;
- selecionar práticas de segurança do paciente para as organizações de saúde;
- monitorar a satisfação e a experiência do paciente com a assistência prestada no
serviço de saude.

## 1.4 Conteúdo programático

- Fundamentos da qualidade, princípios, conceitos, dimensões e tendências
- Auditoria interna/auditoria clínica
- Ciclos de melhoria
- Auditoria externa, certificação e acreditação
- Processo de avaliação
- Segurança do paciente
- Gerenciamento de riscos
- Indicadores – KPIs

- Experiência do paciente
- Repensando a Jornada
- Monitoramento da experiência e satisfação do paciente

## 1.5 Metodologia

Exposições dialogadas, estudos de caso e vivências. Sala invertida. Situação problema.

## 1.6 Critérios de avaliação

- 30% assiduidade e participação. Interação nas atividades.

- 70% prova individual

## 1.7 Bibliografia recomendada

Fonte: RODRIGUES, Marcus Vinícius et al. Qualidade e acreditação em Saúde. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2016. Disponível em: Meus e-books, acessível a partir do ECLASS FGV.

Fonte: SOUSA, P; MENDES, W. Segurança do paciente: conhecendo os riscos nas organizações de saúde. Rio de Janeiro: EAD/ENSP, 2014.

ALVIM, André Luiz Silva. Segurança do paciente em serviços de saude. 2. ed. Curitiba: CRV, 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Fundação Oswaldo Cruz. Gestão de riscos e investigação de eventos adversos relacionados à assistência à saúde. Brasília: Anvisa, 2017.

BRASIL. Ministério da Saude. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Fundação Oswaldo Cruz. Documento de referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Brasília, Ministério da Saúde. 40p, 2014. Disponível em: Documento de referencia para o Programa Nacional de Segurança do Paciente (saude.gov.br) Acesso em: 6 fev. 2023.

COSTA, Diovane Ghignatti et al. Experiência do paciente na coprodução de cuidados: percepções acerca dos protocolos de segurança do paciente. Rev. Latino-Am.

Enfermagem, n° 28, 2020. Disponível em: SciELO - Brasil - Patient experience in co-production of care: perceptions about patient safety protocols Patient experience in co-production of care: perceptions about patient safety protocols Acesso em: 6 fev. 2023.

JOINT COMMISSION INTERNATIONAL. Manual de padrões de acreditação da Joint Commission Internacional para hospitais. Consórcio Brasileiro de Acreditação de Sistemas e Serviços de Saúde. Rio de Janeiro: CBA, 2021.

ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO. Manual brasileiro de acreditação:
Organizações Prestadoras de Serviços de Saúde (OPSS). 2022.

VILLAR, Vanessa Cristina Felippe Lopes; DUARTE, Sabrina da Costa Machado; MARTINS. Mônica. Segurança do paciente no cuidado hospitalar: uma revisão sobre a perspectiva do paciente. Cad. Saúde Pública, n° 36 (12), 18 Dez 2020. Disponível em:

Scielo - Saúde Pública - Segurança do paciente no cuidado hospitalar: uma revisão sobre a perspectiva do paciente Segurança do paciente no cuidado hospitalar: uma revisão sobre a perspectiva do paciente (scielosp.org) Acesso em: 6 fev. 2023.

Andre, Adriana (coord). Gestão de clínicas e hospitais e Indústrias da Saúde 3o.ed., São Paulo. Ed. Atheneu, 2022.

Manual da Federação Brasileira de Hospitais - **https://fbh.com.br/publicacoes-2/**

## *Curriculum vitae* do professor

**Fernando Oetterer Arruda**

Mestre em Administração de Empresas com ênfase em Finanças e Tributos pela FECAP. MBA de Gestão em Saúde pelo Insper. Médico Anestesiologista pela Universidade Federal de São Paulo, com Título Superior em Anestesia pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Título de Administração em Saúde como área de atuação pela Associação Brasileira de Medicina Preventiva e Administração em Saúde - ABRAMPAS. Yellow Belt em Lean 6 Sigma na Saúde.

Ocupou cargos de gestor médico em hospitais, empresas públicas e privadas, além de atuar em carreira acadêmica de cursos de medicina e administração em saúde. Professor convidado da Educação Executiva da Fundação Getúlio Vargas no MBA em Gestão de Clínicas, Hospitais e Indústrias da Saúde na disciplina de Gestão Clínica e Melhores Práticas e no MBA Executivo em Administração: Gestão de Saúde na disciplina de Empreendedorismo em Saúde.

## 2. Texto para estudo

Elaborar estratégias, revisar os planos de ação e alavancar a performance da empresa compreendem o dia a dia do gestor.

Para tornar o ambiente ainda mais desafiador à gestão, é importante acrescentar que as expectativas dos usuários também são diferentes, dada a quantidade de informação, nem sempre acurada, a que todos têm acesso através da mídia e redes sociais.

A resposta para todas estas demandas ao gestor é apresentada através da necessidade de uma agenda de fortalecimento dos princípios de governança, gestão de risco e qualidade nas organizações. Assim, a transparência e equidade para todos os *stakeholders* se torna possível e a imagem da organização é continuamente apoiada em princípios de integridade e melhores práticas.

No contexto atual, a gestão dos processos de forma estratégica e especializada, com foco em alta performance, norteia o desenvolvimento de programas de liderança e qualidade nas organizações.

Tal conhecimento é aplicável a qualquer seguimento da área da saúde, à medida que os princípios e diretrizes estão relacionados e podem ser adaptados a realidade de cada serviço.

Implementar a cultura de melhoria contínua, integridade e conformidade, requer conhecimento técnico associado à capacidade de engajar pessoas. O desenvolvimento de processos seguros, através do uso de tecnologia, gestão de pessoas e visão sistêmica não pode ser visto como atividade individual ou adicional, mas, através das ferramentas e práticas de liderança adequadas, pode ser incorporado às atividades da organização e impactar positivamente todos os *stakeholders*.

A conformidade e a qualidade são percebidas em organizações que possuem práticas de segurança do paciente e que se pautam pelo comportamento ético, buscando direcionar seus recursos e capacidades para atingir as expectativas do usuário. Tais ações se refletem na redução de custos e tornam o sistema de saúde mais sustentável.

A ideia de abordar qualidade como programa serve para reforçar o conhecimento de que existe continuidade nas ações, de acordo com as constantes mudanças no ambiente externo e interno e em alinhamento com o planejamento estratégico. Portanto, a liderança clínica e os programas de qualidade representam um organismo, que permeia toda a organização, incluindo tecnologia, pessoas e o próprio negócio.

Os processos de certificação e acreditação, por sua vez, apoiam organizações e equipes através de auditoria, análise de pontos de melhoria e sistematização de processos seguros, de acordo com as normas, regras e procedimentos próprios de cada atividade.

Catalisar mudanças e melhorias que alavanquem a performance da empresa demanda o desenvolvimento e acompanhamento de indicadores

chave de performance (KPIs) que coordenem as práticas assistenciais, a qualidade e o cuidado baseado em valor. O conhecimento dos mecanismos de planejamento, organização, liderança e controle possibilitam constantes avanços e transformações positivas na organização, tais como:

- Pesquisa e implantação de terapias e métodos diagnósticos de acordo com as melhores evidências científicas
- Desenvolvimento de processos seguros e eficientes
- Análise de dados e aceleração da transformação digital com foco em desfecho
- Apoio à área comercial e cadeia de suprimentos para aprimorar a sustentabilidade ao negócio
- Participação objetiva na maximização do resultado operacional da empresa, incluindo as iniciativas que englobem responsabilidade social, ambiental e governança (ESG)
- Direcionamento dos sistemas de saúde para o sentido da excelência e criação de valor

Sob o ponto de vista prático a construção dos indicadores deve ser dirigida de forma a refletir claramente o desfecho esperado, levando em conta os objetivos definidos para o serviço e as métricas correspondentes à performance esperada.

Assim, as principais características do indicador ideal de performance são:

- Comparável com outros referenciais e demais serviços;
- Capacidade de direcionar a equipe para boas práticas, seguindo as melhores diretrizes e evidências científicas;
- Temporal, possibilitando analisar a evolução ao longo do tempo;
- Facilmente interpretado;
- Clara relação com os elementos monitorados, refletindo a performance e detectando inadequações;
- Confiável quanto a fonte de dados;

- Extraído, compilado e analisado com a frequência adequada
- Baixo custo quanto à obtenção dos dados

## Fundamentos da gestão da qualidade e segurança do paciente

Através da verificação do alinhamento da estratégia aos critérios de conformidade e considerando a performance da empresa, o gestor constata a importância de prover assistência que atenda às expectativas do usuário, incluindo as mais modernas diretrizes e os recursos adequados, sempre priorizando a segurança do paciente. Através destes pilares, a qualidade em saúde se apresenta como um processo chave.

A gestão da qualidade e segurança associada à multiplicação para todas as áreas, conduz a organização para o sentido de trazer maior relevância às entregas das equipes e confere fluidez aos processos, já que a padronização da comunicação e o alinhamento dos indicadores chave (KPI) permite o compartilhamento de metas e seus respectivos resultados.

Portanto, a área da qualidade, pautada pelos princípios de governança e objetivos da organização, desenvolve ações e processos que apoiam o gestor de forma a ajustar continuamente produtos ou serviços para que estes caminhem ao encontro das expectativas do usuário.

A evolução da qualidade em saúde, desde o final do século XIX envolveu a transição entre a abordagem das questões relativas a arquitetura hospitalar e padronizações de critérios para escolas médicas até a definição de corpo clínico e padronização de prontuário.

No século XX, as organizações passaram a se apropriar das metodologias de gestão da qualidade e foram, gradualmente, definindo padrões de segurança e análise de resultados assistenciais.

Donabedian (1988) desenvolveu a teoria de sistemas, onde os resultados são definidos através da otimização de estrutura (área física, equipamentos, insumos e recursos humanos) e processos de trabalho

(aplicação correta de procedimentos e tecnologia). Esta metodologia de gestão da qualidade, incialmente desenvolvida na indústria de produção, passou a ser utilizada na área da saúde.

Além de Donabedian, diversos autores buscaram definir o conceito de qualidade. Para Deming (1986) qualidade é tudo aquilo que melhora o produto sob o ponto de vista do cliente. Segundo Juran (1995), é a ausência de deficiências e adequação ao uso. Outra contribuição importante para sintetizar o conceito de qualidade veio de Crosby (1989) onde: ”Qualidade é fazer o certo na primeira vez.”

Na área da saúde, o Institute of Medicine (IOM, 1998) define que qualidade é o grau com que os serviços de saúde, voltados para cuidar de pacientes individuais ou de populações, aumentam a chance de produzir os resultados desejados e são consistentes com o conhecimento profissional atual.

Apoiadas pelos fundamentos de qualidade e segurança, as mudanças foram significativamente aceleradas na década de 90, por meio de publicações sucessivas, dentre elas o livro do IOM intitulado Errar é Humano: Construindo um Sistema de Saúde Mais Seguro (2000).

Estatísticas recentes chegam a estimar que morrem mais de 220mil pessoas por ano no Brasil por falhas na assistência hospitalar e que três pacientes morrem a cada cinco minutos por causas evitáveis.

Portanto, a importância estratégica da qualidade em saúde nos dias de hoje está muito mais consolidada e sabidamente proporciona um cuidado seguro e ao mesmo tempo, favorece abordagem sistêmica para criar valor ao usuário.

Sob o ponto de vista prático, a qualidade é modernamente preconizada em toda a jornada de saúde, desde a atenção primária, promoção e prevenção, atendimentos ambulatoriais, exames, internações, até a continuidade dos cuidados pós alta hospitalar. Em outras palavras, o gestor deve ter em mente que o cuidado coordenado e integral se beneficia dos instrumentos e práticas de melhoria contínua.

Para avaliar a qualidade assistencial torna-se necessário um conjunto de instrumentos capazes de identificar tanto aspectos relacionados àqueles três elementos básicos do sistema – estrutura, processo e resultado – quanto àqueles relativos à percepção das pessoas que utilizam estes serviços. Seja qual for o instrumento utilizado, sua aplicação será materializada através de alguma forma de auditoria, entendida aqui como algum processo de exame e validação de um sistema, de uma atividade ou informação.

Como parte integrante dos fundamentos de gestão da qualidade, o processo de melhoria contínua é tema de importância central. Além do domínio das ferramentas e gestão por processos, a visão sistêmica pode, de forma didática, ser construída a partir dos seguintes níveis:

- Estratégico: a qualidade se insere a partir do conhecimento da missão, visão e valores da organização. Neste quesito são avaliados os objetivos da organização, sua cultura e o papel da liderança em apoiar todos os processos chave, seguindo diretrizes técnicas, éticas e de boas práticas. O termo *accountability* é frequentemente trazido neste nível de avaliação e consiste em mecanismos que direcionam os gestores à prestação de contas, determinando a responsabilidade dos mesmos pelo resultado de suas ações. Esta análise é de extrema relevância e tem sido desdobrada sob ótica que extrapola as metas de maximização do resultado operacional da empresa, mas também engloba responsabilidade social, ambiental e governança.

- Tático: gestores das diversas áreas da organização são apoiados pela qualidade para auditar a evolução de seus processos, detectar circunstância de risco, eventuais oportunidades de melhoria e, após definição adequada dos fatores contribuintes e influenciadores da performance, elaborar e implementar planos de ação. A qualidade participa dos processos de análise de eventos adversos, em sinergia com o núcleo de segurança do paciente e com as comissões obrigatórias (ética, SCIH, óbito, prontuários etc.),

analisando as causas que levaram ao evento e gerando ações para detectar, prevenir e tratar tais ocorrências.

- Operacional: a área de qualidade funciona como catalisador e multiplicador de boas práticas, buscando garantir a conexão entre os valores da empresa com o serviço ou produto que de fato chega ao usuário. Informação clara e processos seguros em todos os níveis da organização geram sensação de pertencimento e estimulam o comprometimento por parte dos colaboradores com o cuidado adequado e humano e assim, a experiência do usuário é impactada de forma positiva.

De acordo com os aspectos destacados acima, a liderança deve garantir, como passo inicial, a conformidade com relação às normas técnicas, diretrizes atualizadas e legislação. Estes itens se referem ao cuidado seguro e de acordo com normas de boas práticas e representam uma sólida fundação para qualquer organização que se propõe a atingir a excelência.

Referenciais externos, incluindo entidades de classe, órgãos regulatórios e associações, disponibilizam material específico com os requisitos, servindo de apoio ao gestor na elaboração de protocolos técnicos e assistenciais, descrição de procedimentos operacionais e checklists de conformidade e segurança. Ainda nesta etapa, deve ser realizada a verificação dos fluxos de atendimento, assinatura de termos de consentimento, acordo de nível de serviços (SLAs) e registros adequados em prontuário.

Quando se trata de serviços de saúde, as metas internacionais de segurança: na identificação, comunicação, prescrição e administração de medicamentos, nos procedimentos cirúrgicos, higienização das mãos e para redução de quedas e úlceras por pressão; servem de referência para o desenvolvimento de ações que a organização não pode deixar de garantir desde o início de suas atividades.

A próxima etapa no processo de qualidade é a definição e formalização de protocolos baseados em evidência específicos e gerenciáveis, acompanhados pelo monitoramento contínuo por parte do gestor.

De acordo com práticas de melhoria contínua em busca da excelência, a qualidade utiliza indicadores de gestão em integração com todas as áreas e níveis organizacionais, permitindo que os recursos e capacidades estejam em constantes ciclos de aprimoramento. Os indicadores de performance e risco devem ser definidos sob critérios quantitativos e qualitativos.

Auditorias de verificação na adequação dos registros e adesão aos protocolos permitem a mensuração de aspectos quantitativos, de acordo com itens considerados conformes e não conformes.

Com relação à avaliação qualitativa, o gestor deve buscar indicadores que avaliem se o plano de cuidados proposto está sendo cumprido e confirmem que o desfecho se apresenta de acordo com o esperado para o caso. Esta análise deve considerar tanto o resultado imediato, quanto o acompanhamento após alta ou término do atendimento.

O indicador, portanto, deve ser padronizado, de fácil entendimento por parte de todos os envolvidos, confiável quanto à fonte de dados, comparável com outros referenciais e possibilitar análise de sua evolução ao longo do tempo.

Como exemplo pode-se destacar o indicador de prevalência, que mede a proporção de pessoas em uma dada população que apresentam um determinado risco ou evento. Outro exemplo é o indicador de efetividade na prevenção, que avalia a proporção de indivíduos com risco e sem o evento em comparação com o total de indivíduos com risco.

A partir do conhecimento e implementação das etapas descritas acima, a organização possui a gestão da qualidade devidamente sistematizada e, assim, o processo técnico e prático é incorporado conforme se segue.

O conhecimento de metodologias estatísticas simples pode facilitar em todas as etapas. A sequência "DCOVA" que inclui: definir, coletar, organizar, visualizar e analisar os dados é de simples operacionalização e possibilita o raciocínio lógico para o emprego das ferramentas da qualidade nas atividades de: definir as variáveis a serem estudadas; coletar os dados

através de fontes adequadas; organizar os dados coletados em planilhas com as variáveis devidamente categorizadas; visualizar os dados através de tabelas buscando padrões ou relações entre as mesmas; analisar de forma apropriada para que, assim, as conclusões apareçam.

Esta análise sistemática dos dados, possibilita o agrupamento em classes padronizadas (categorias), facilitando o encontro da causa fundamental de um problema.

Planilhas e listas de verificação, associadas a tabelas de visualização servem tanto para controle de qualidade nas diversas fases de análise como para seu planejamento.

A estratificação dos dados em listas de verificação ou gráficos, permite adicionalmente, o uso do conceito de diagrama de Pareto, onde se observa que em grande parte dos casos, o problema está associado a um pequeno número de causas. Esta teoria facilita o direcionamento das ações para aquelas mais efetivas.

Assim, a coleta de dados estruturados, definição do problema, sistematização das ações, seguidas de verificação dos resultados e revisão das atividades constitui o arcabouço estrutural básico do ciclo de melhoria contínua, sendo também tratado como ciclo PDCA (plan, do, check, act).

As etapas deste método de análise e solução de problemas envolvem:

P (Plan): análise e definição do problema, identificação das causas, determinação de prioridades, elaboração de metas específicas para resolução e estabelecimento do plano de ação.

D (do): execução do plano de ação

C (check): verificação

A (act): ações e ajustes a serem executados de acordo com o verificado

Apesar de existirem outros métodos de resolução de problemas, o PDCA, ou ciclo de Deming, originário do sistema de gerenciamento da qualidade total (TQM), possui ótima aplicabilidade, facilita a obtenção de resultados e incremento de performance.

Com o intuito de evitar falhas na análise e no plano de ação, é fundamental que o gestor defina adequadamente o problema e invista tempo e energia na etapa de planejamento.

O gestor deve estar atento ao método, já que frequentemente são trazidas abordagens sobre falta de determinado recurso como sendo o problema, isso já seria uma das possíveis causas que levaram ao real problema (efeito). Como exemplo, pode-se destacar a frase: "A falta de materiais específicos e padronizados para determinada cirurgia gera a necessidade de adaptações ou compras eventuais e isto aumenta os custos do processo cirúrgico". Observe que o problema, neste caso, é o alto custo operacional do processo cirúrgico.

Para facilitar a importante fase de definição do problema, deve-se entender qual seria o resultado esperado e compará-lo com o resultado obtido, de forma objetiva e mensurável. A seguir, reconhecer suas características, principais causas e, por fim, quais seriam as medidas para correção.

Diante de um efeito (problema) definido, o processo de análise das causas é apoiado por algumas ferramentas, dentre as quais pode-se destacar a análise de causa raiz, os 5 "porquês" e o diagrama de Ishikawa. A escolha da ferramenta ideal de análise pode variar e o gestor interage com a equipe de qualidade para a definição de qual será a mais adequada, considerando as características do problema e o perfil da organização.

A análise direta de causa raiz ou através dos 5" porquês" é mais utilizada para situações em que poucas causas possíveis são previstas. Em sequência, diante do problema, são realizadas perguntas ("porquês") até que seja atingida a principal causa. Por exemplo: Por que o funcionário faltou? Porque está licenciado. Por que está licenciado? Porque teve uma distensão na coluna lombar. Por que teve a lesão? Porque não utilizou o equipamento adequado para mobilizar o paciente. Por que não utilizou o equipamento? Porque não estava disponível. Por que não estava disponível? Porque está quebrado.

Já o diagrama de Ishikawa envolve a elaboração e categorização de causas, fatores contribuintes e influenciadores, de forma a gerar o entendimento dos fatores que provocaram o efeito.

Normalmente se utilizam os "6Ms para categorizar as causas:

Mão de obra: colaboradores envolvidos em determinada atividade

Métodos: rotinas e procedimentos

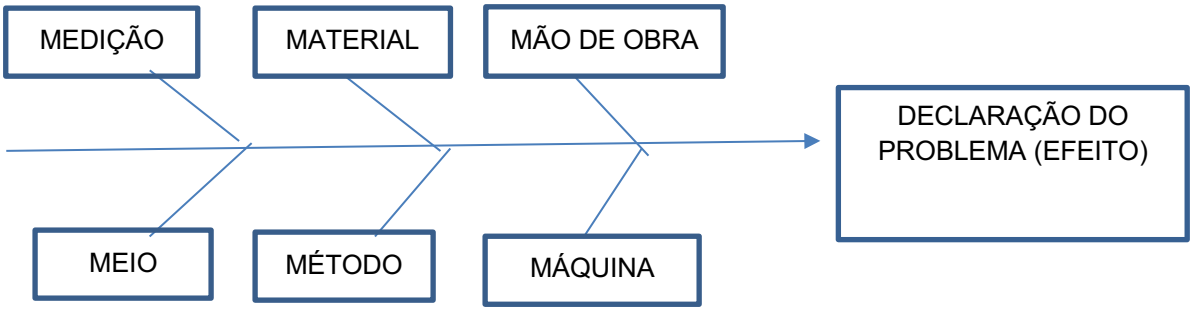
Materiais: insumos e medicamentos

Máquinas: equipamentos

Meio ambiente: condição de trabalho, ergonomia, arquitetura

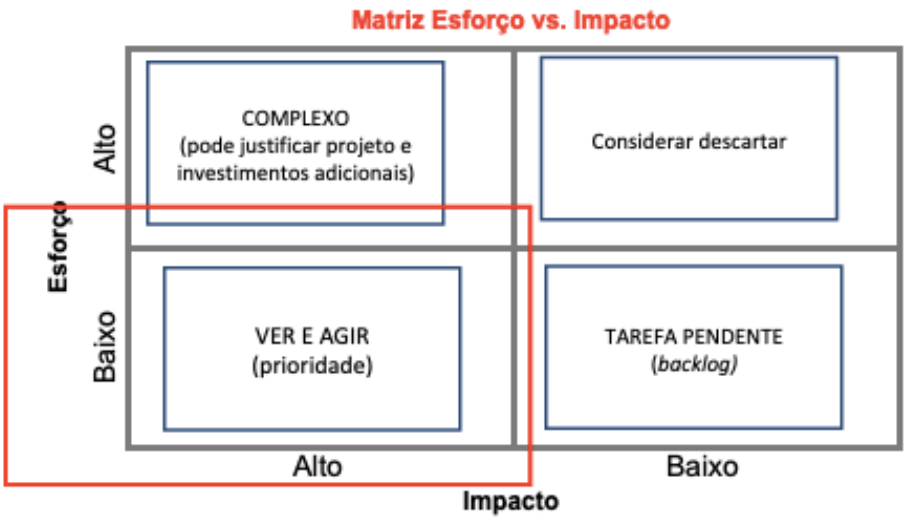
Medidas: forma de obtenção dos dados, mensuração e elaboração de indicadores

A seguir, é construído um diagrama, conhecido como "espinha de peixe", ou de causa-efeito, conforme abaixo:




Após definição adequada do problema e análise das causas, vale ressaltar que nem todas as ações para resolução são de simples execução e, além disso os custos associados podem ser altos, sob o ponto de vista financeiro direto ou pelo tempo gasto para a efetiva implementação. O uso de critérios de prioridade é bastante útil para a definição de quais ações serão desencadeadas. A matriz esforço-impacto e a ferramenta GUT podem ser úteis neste momento.

Através da localização de cada uma das ações em um quadrante, a equipe pode definir quais serão as frentes de trabalho e assim, entregar resultados com maior eficiência e agilidade.




No caso da ferramenta GUT, com o intuito de definir prioridades, a equipe gera um diagrama de tomada de decisão, com critérios de: gravidade (impacto sobre o resultado/operação); urgência (tempo disponível ou necessário para resolver); tendência (potencial agravamento enquanto não for resolvido). Para cada um dos 3 itens são dadas pontuações de 1 a 5 e é montada uma tabela com o resultado da multiplicação dos pontos, compondo o critério de prioridade conforme abaixo:

| PROBLEMA | G | U | T | G x U x T |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**Gravidade**: 1. sem gravidade; 2. pouco grave; 3. Grave; 4. Muito grave; 5. Extremamente grave
**Urgência**: 1. Não tem pressa; 2. Pode esperar; 3. O mais cedo possível; 4. Com alguma urgência; 5. Ação imediata
**Tendência**: 1. Não vai piorar; 2. Piora em longo prazo; 3. Piora em médio prazo; 4. Piora em curto prazo; 5. Piora rapidamente

Através da sequência definida até o momento, a elaboração do plano de ação será realizada de forma adequada e assertiva. Nesta etapa, são descritas as ações de forma específica para cada unidade ou área envolvida, por meio da ferramenta 5W2H.

A experiência desenvolvida através do uso desta ferramenta tem conduzido à inserção de um terceiro "H", que envolve a definição de como será medido o resultado (*How to measure)*, reforçando a importância da elaboração de indicadores para acompanhamento.

Além da resposta a situações ou ocorrências presentes na organização, a gestão da qualidade deve contemplar ações que tragam maior confiabilidade, através do mapeamento de riscos. Trata-se de avaliação prospectiva que busca melhorar as etapas do processo, reduzindo as chances de falhas.

Uma das ferramentas utilizadas para este fim é o FMEA (failure mode and effect analysis). Este método permite a investigação sistematizada e insere critérios de prioridade para as ações de contenção e prevenção.

De acordo com os possíveis riscos detectados no processo, a equipe avalia e determina pontuações para: gravidade (o efeito da falha pode causar dano?); ocorrência (processos semelhantes apresentam esta falha?); detecção (qual a probabilidade de evidenciar a falha caso ela se apresente?).

Geralmente, utiliza-se a escala de 1 a 10 para hierarquizar os itens analisados pelo FMEA.

**Escala/pesos para os itens: Ocorrência de causa (O) e Gravidade do Efeito (G)**

| Nunca | Raramente | Muito baixa | Baixo | Moderado para baixo | Moderado | Moderada para alta | Alta | Muito Alta | Sempre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

**Escala/pesos para os itens: Detecção de Falha (D)**

| Nunca | Raramente | Muito baixa | Baixo | Moderado para baixo | Moderado | Moderada para alta | Alta | Muito Alta | Sempre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

A multiplicação dos 3 itens gera o NPR (número de prioridade de riscos), que varia de um a mil, devendo ser recalculado após as correções para verificar a efetividade da ação corretiva para cada modo de falha, trazendo assim, maior confiabilidade ao processo.

Após definição das medidas a serem priorizadas, ao desencadear ações de melhoria, o gestor deve estar atento e focar em ações fortes, que possibilitem que processos críticos sejam seguros e previsíveis. Como exemplo de ações fortes, pode-se citar mudanças estruturais, físicas e arquitetônicas; controles e travas de engenharia; simplificação de processos; remoção de etapas desnecessárias e padronização de equipamentos.

Esta hierarquia de efetividade não tem o objetivo de contraindicar nenhuma iniciativa ou ação de melhoria, mas sim iluminar para a equipe que está elaborando o plano de ação, quais são as medidas que têm comprovadamente maior potencial em contribuir para a segurança e previsibilidade dos processos, reduzindo a possibilidade de falha humana.

Além das ações que tornam os processos mais seguros e confiáveis, a qualidade pode contribuir para a remoção de desperdícios através do empenho da filosofia Lean. A engenharia de mapeamento de tempos e movimentos traz a oportunidade de detecção de etapas ou atividades que não agregam valor ao usuário. Como exemplo de desperdício é frequente detectar: estoques acima do necessário, filas de espera, excesso de movimentação de pessoas e equipamentos, A equipe detecta desperdícios e desenvolve ações que busquem maior fluidez operacional, agilidade, flexibilidade, ergonomia e redução de custos.

A metodologia de gestão da qualidade e gerenciamento de riscos serve de base para a construção do núcleo de segurança do paciente (NSP), de acordo com a portaria nº 529/2013 do Ministério da Saúde e é utilizada para apoiar na detecção e análise de circunstâncias de risco e eventos adversos, além de promover a cultura de segurança na organização.

As ocorrências detectadas ou notificadas ao NSP são geralmente categorizadas conforme abaixo:

- Circunstância de risco: houve potencial significativo de dano, mas o incidente não ocorreu. Ex: o equipamento de raio X está quebrado, apesar de seu uso não ter sido necessário.
- Quase-erro (*near miss)*: incidente que foi interceptado de forma planejada ou ao acaso e acabou não atingindo o paciente. Ex: ao checar a bolsa de sangue fornecida pelo setor, a profissional de enfermagem observou que o tipo sanguíneo não era compatível e não administrou.

- Incidente sem dano: evento que ocorreu, mas sem causar dano ao paciente. Ex: paciente recebeu um medicamento analgésico diferente daquele que havia sido prescrito e não apresentou nenhuma reação adversa
- Evento com dano leve: incidente que gera dano leve e rapidamente reversível. Ex: paciente ficou aguardando um procedimento em jejum por 8 horas, porém o equipamento quebrou e houve necessidade de agendar para outra data
- Evento com dano moderado: incidente que gerou lesão ou perda de função, com necessidade de intervenção ou terapia adicional à prevista para o quadro de base. Ex: paciente diabética recebeu soro com glicose e houve necessidade de administração de insulina e maior tempo de internação
- Evento com dano grave: incidente que gerou necessidade de intervenção intensiva (clínica ou cirúrgica) para salvar a vida ou causou dano permanente ou a longo prazo. Ex: paciente caiu do leito e fraturou o crânio
- Evento com óbito: incidente catastrófico que causou ou antecipou o óbito. Ex: transfusão de sangue em paciente errado, levando a reação hemolítica, parada cardíaca e óbito.

Frente a evento óbito, o NSP deve realizar avaliação sistêmica, incluindo cronologia dos fatos, entrevista com todos os envolvidos, identificação de fatores contribuintes e influenciadores. Esta análise exaustiva e estruturada, seguindo a metodologia descrita ao longo deste capítulo é conhecida como protocolo de Londres.

## Acreditação em saúde

A acreditação é uma certificação concedida por uma entidade nacional ou internacional, pública ou privada, a um serviço de saúde que atende a determinados padrões previamente estabelecidos de qualidade e segurança (do paciente, dos profissionais e da organização como um todo).

Trata-se de uma metodologia de gestão que busca preencher lacunas, remover deficiências, estabelecer uma cultura de melhoria contínua e de excelência, tanto gerencial, quanto assistencial.

A auditoria externa, como o nome sugere, é realizada por equipe de alguma entidade, separada e distinta da organização de saúde, normalmente convidada por esta para aplicar alguma ferramenta de avaliação com vistas a um processo de certificação, acreditação ou simplesmente para submeter-se a um diagnóstico organizacional voluntário ou relacionado a algum programa específico.

Embora existam inúmeras diferenças nas várias ferramentas de avaliação, o processo de exame e validação de todas elas caracteriza-se muito mais pelas semelhanças existentes do que pelas diferenças. Tais semelhanças são caracterizadas pela necessidade, durante o processo de avaliação ou auditoria, da busca por dados que caracterizam a organização de saúde por evidências objetivas, sejam documentais, observacionais ou resultantes de entrevistas, que demonstrem o cumprimento de requisitos, alinhamento com fundamentos e cumprimento de padrões, todos eles definidos pela ferramenta em uso.

Na maioria das vezes, tais requisitos, fundamentos ou padrões permeiam a organização de forma transversal, sendo necessárias visitas às principais áreas, onde são feitas entrevistas com colaboradores, usuários e acompanhantes, com a intenção de verificar se o serviço possui estrutura e processos que estejam de acordo com normas e regulamentações de boas práticas.

De acordo com os mecanismos apresentados neste capítulo para a gestão da qualidade e segurança, o serviço de saúde escolhe a organização acreditadora e dá início ao processo de auditoria externa. Geralmente são realizadas visitas diagnósticas prévias e as áreas recebem feedback sobre os principais ajustes antes do momento da visita de avaliação.

Apesar da crescente busca por selos de acreditação, poucos hospitais possuem este diferencial no Brasil. Diante deste cenário, a ANS publicou a lei 13.003/2014 que define o fator de qualidade. Foram criadas regras para reajuste na renovação de contratos dos hospitais privados com os sistemas de saúde suplementar, buscando favorecer serviços acreditados.

Implementar processos de acreditação proporciona melhoria na qualidade assistencial, fortalecimento da equipe de saúde, estímulo à área de educação continuada, criação de instrumentos de gerenciamento da instituição, além de contribuir para segurança de equipes e pacientes,

Dentro do escopo da acreditação, a equipe de auditoria externa avalia o papel da liderança no suporte e fortalecimento das boas práticas, de acordo com as atuais diretrizes e com foco nos objetivos da organização.

Ao término da visita é gerado um relatório de auditoria, contendo o grau de conformidade do serviço, principais pontos fortes, não conformidades e oportunidades de melhoria. A seguir, de acordo com os critérios mencionados, é definido pela organização acreditadora qual é o nível de evolução do serviço ou organização.

## A Evolução da Experiência do Paciente: Da Percepção à Segurança Clínica

A Experiência do Paciente (PX) consolidou-se como um dos pilares fundamentais da saúde suplementar e pública, indo muito além da hotelaria ou da cortesia no atendimento. Definida como a soma de todas as interações moldadas pela cultura organizacional, a PX atualmente é entendida sob a ótica da Experiência Humana. Isso significa que a percepção do paciente é influenciada não apenas pelo desfecho clínico, mas pela fluidez dos processos digitais, pela clareza na comunicação e pela empatia demonstrada pelo corpo assistencial em cada ponto de contato da jornada.

Para medir essa jornada de forma técnica e precisa, as instituições migraram de métricas genéricas para indicadores específicos como o H-NPS (Hospital Net Promoter Score) e o CES (Customer Effort Score). Enquanto o H-NPS ajusta a sensibilidade da recomendação à complexidade do cuidado hospitalar, o CES monitora o nível de esforço que o paciente despende para acessar o sistema. O uso de Inteligência Artificial para análise de sentimento em tempo real permite que os gestores identifiquem "pontos de dor" imediatamente, transformando feedbacks subjetivos em dados acionáveis que orientam a melhoria contínua da operação.

A conexão entre a experiência e a Gestão da Qualidade é intrínseca: um serviço de alta qualidade é, por definição, aquele que entrega valor sob a perspectiva do cliente. Quando os indicadores de experiência apontam falhas na comunicação ou na continuidade do cuidado, eles estão, na verdade, sinalizando gargalos operacionais que comprometem a eficiência da instituição. Portanto, a gestão moderna utiliza a "Voz do Paciente" como um termômetro para auditar processos, validar protocolos e garantir que a entrega do serviço esteja alinhada aos padrões de acreditação nacionais e internacionais.

Por fim, a Segurança do Paciente é o alicerce onde a experiência se sustenta. Estudos contemporâneos demonstram que pacientes que reportam uma melhor experiência apresentam maior adesão ao tratamento e menores taxas de reinternação e eventos adversos. Um paciente que compreende as orientações da equipe (baixo esforço de compreensão) é um agente ativo na prevenção de erros. Assim, integrar PX, Qualidade e Segurança não é apenas uma estratégia de diferenciação no mercado, mas uma necessidade ética e operacional para garantir a sustentabilidade e a excelência do cuidado em saúde.

## Conclusão

O conceito de Quadruple Aim (ou quádrupla meta) do *Institute for Healthcare Improvement* (IHI), sintetiza a importância estratégica da gestão da qualidade, visão sistêmica e impactos nos custos. O modelo traz o olhar da conexão entre quatro pilares ou metas:

- Experiência do paciente: através de assistência segura, efetiva e focada nas expectativas do usuário
- Melhor saúde da população: atenção a medidas de prevenção e promoção, aspectos relacionados à atenção primária
- Redução de custos: diminuição do custo per capita, uso racional dos recursos
- Engajamento da força de trabalho: esta quarta dimensão, trazida durante a trajetória de implementação do modelo, trata da busca pela percepção de alegria e significado ao trabalho por parte dos profissionais. Percebe-se, cada vez mais, que existe a necessidade de atenção ao ambiente de trabalho, garantindo que os colaboradores não sofram danos físicos ou psicológicos.

Através da conexão e sinergia entre estes quatro fatores, as lideranças têm em seu radar a devida atenção ao indivíduo, aos profissionais envolvidos no cuidado, ao sistema de saúde e à sociedade.